

УДК: 618.19-006-08

Г.А.Тлеугабилова, Б.Ш.Кожажметов, Р.Р.Абдулаханова, Ж.Ж.Калиева
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей

Лечение дисгормональных нарушений молочной железы

Аннотация. Применение растительного препарата Мастодион может способствовать достоверному снижению болевого синдрома уже с первой недели терапии. У больных со средней степенью тяжести фиброзно-кистозной, диффузной формой мастопатий эффективность Мастодиона составила 72,5%, а с тяжелой формой - 35,2%. Мастодион является эффективным и безопасным средством для нормализации гормонального баланса при различных формах мастопатий, формирующихся фиброаденом. Полученные результаты свидетельствуют о том, что определились новые пути коррекции дисгормональных нарушений молочной железы. Использование препарата Мастодион открывает новое направление в терапии указанных нарушений - целенаправленно воздействующая терапия. Такая терапия должна стать приоритетной у практических врачей при лечении дисгормональных нарушений молочной железы.

Ключевые слова: опухоли кожи, ранняя диагностика.

Введение

По статистическим данным за последние годы увеличилось число пациенток, обращающихся к специалисту по поводу гиперпластических нарушений молочной железы. Самым распространенным среди них является мастопатия, встречающаяся у 20-40% женщин в возрасте от 20 до 50 лет. Мастопатию как дисгормональное нарушение впервые описал J. Velpeau в 1838 г.

По определению ВОЗ мастопатия как дисгормональное нарушение характеризуется широким спектром пролиферативных и регрессивных изменений тканей молочной железы с явлениями эпителиального и соединительнотканного компонентов. Дисгормональные гиперплазии молочных желез, происходящие вне периода лактации и беременности - наиболее распространенные нарушения репродуктивных органов женщины. Молочные железы являются органом-мишенью для половых гормонов яичников, эстроген-гестагенные нарушения играют определяющую роль в регуляции морфологических и гистологических изменений в тканях молочной железы [1].

Рак молочной железы возникает в 3-5 раз чаще на фоне доброкачественных заболеваний молочной железы и в 30-40 раз чаще при некоторых формах узловой мастопатии [2].

За весь репродуктивный период в молочных железах женщины происходит 480 циклов пролиферативных и регрессивных изменений. Нарушение регуляции этих процессов приводит к диффузным перестройкам. Они проявляются в виде диффузных и диффузно-узловых изменений. Различают несколько форм диффузных мастопатий, которые находят свое отображение на

рентгенограммах и при морфологическом исследовании:

- диффузная мастопатия с преобладанием железистого компонента (аденоз);
- диффузная фиброзно-кистозная мастопатия (ФКМ) с преобладанием фиброзного компонента;
- диффузная ФКМ с преобладанием кистозного компонента;
- смешанная форма диффузной ФКМ;
- склерозирующий аденоз [3].

Сейчас уже известны молекулярные механизмы, приводящие к развитию пролиферативных процессов в молочных железах. Среди них можно выделить три основных внутриклеточных механизма. Это: 1) гормональный (или эстроген-зависимый) путь; 2) путь, индуцируемый ростовыми факторами; 3) путь, активируемый противовоспалительными цитокинами. Многолетние поиски природных соединений, блокирующих развитие гиперпластических процессов в гормон-зависимых тканях, наконец, увенчались успехом. Одним из таких препаратов растительного происхождения является Мастодион. К основным фармакологическим эффектам препарата относится: нормализация метаболизма эстрогенов, блокада сигнальных путей, индуцированных ростовыми факторами и цитокинами [4,5].

Цель исследования

- изучение новых возможностей терапии Мастодионом при дисгормональных нарушениях молочной железы.

Материал и методы

Комплексно обследовано более 30 женщин. Обследование включало клинический осмотр, маммографию, ультразвуковое исследование, осмотр гинеколога, консультацию эндокринолога.

Выделены группы больных с различными формами фиброзно-кистозной мастопатии (ФКМ) (N=30) в возрасте от 18 до 67 лет со следующими нозологическими формами:

- выраженная ФКМ с преобладанием кистозного компонента - 10 (33,3 %);
- выраженная ФКМ с преобладанием фиброзного компонента - 8 (26,6 %);
- диффузная мастопатия с преобладанием железистого компонента (аденоз) - 8 (26,6 %);
- формирующаяся фиброаденома - 2 (6,6 %);
- внутрипротоковые образования - 2 (6,6 %) на фоне ФКМ.

22 (73,3 %) больных предъявляли жалобы на боли (масталгии) в молочных железах. Уплотнение в молочных железах пальпировалось у 14 (46,6%), сопутствующая патология - у 18 (60 %). Сопутствующие заболевания включали миому матки - 2 (6,6 %), эндометриоз - 3 (10%), хронический аднексит, спаечный процесс в малом тазу - 6

(20 %), тиреоидит - 11 (36,6 %), узловой зоб - 4 (13,3%).

При рентгенологическом исследовании у больных с выраженной ФКМ с преобладанием кистозного компонента на фоне железистой гиперплазии и умеренного фиброза стромы имеются множественные округлые и овоидные образования различной величины от 0,5 до 4-6 см с четкими ровными контурами.

Рентгенологическая картина смешанной формы мастопатии характеризуется перестройкой структуры железистой ткани с наличием множественных участков затемнения и просветления различной формы и величины. На фоне диффузной перестройки могут выделяться отчетливые тени отдельных кист. При ультразвуковом исследовании (УЗИ) диаметр кист колебался от 0,7 до 4 см с четкими ровными контурами.

Рентгенологически склерозирующий аденоз определяется участками гиперплазии железистой ткани в виде нерезко очерченных очагов уплотнения, чаще округлой формы. При УЗИ узловых образований выявлено не было.

В 6,6% при подозрении на внутримолочные образования проводилось цитологическое исследование серозных выделений из сосков молочной железы. У больной К., 55 лет в анамнезе 22 года назад была фибросаркома левой лопатки. Состояние после краевой резекции лопатки с опухолью и лучевой терапии. (Гистологическое заключение № 4500-4522 от 15.03.89. - дифференцированная фибросаркома). У этой же больной 2 года назад была произведена секторальная резекция левой молочной железы по поводу склерозирующего аденоза. В 12% случаев при подозрении на рак проводилась пункционная биопсия с цитологическим исследованием. Больным с сопутствующими заболеваниями проводилось дополнительное обследование, включающее анализ крови на гормоны (ТТГ, Т3, Т4, ЛТГ, ФСГ, эстрадиол, прогестерон и пролактин), УЗИ щитовидной железы, яичников, гинекологическое обследование. У 8,2% пациенток было повышенное содержание эстрогена в крови, 3,4% - повышение уровня Т3 гормона щитовидной железы.

Результаты и обсуждение

Мастодином назначался 30 больным с мастопатией, фиброаденозом, формирующейся фиброаденомой по 1 таблетке 2 раза в день в течение 3 месяцев с обязательным дополнительным лечением сопутствующей патологии и динамическим контролем.

Через 3 месяца пациентам был проведен контроль, включающий клинический осмотр, маммографию (женщинам старше 35 лет), УЗИ (до 35 лет) и дополнительное обследование больных с сопутствующей патологией (анализ крови на гормоны, УЗИ щитовидной железы, яичников, гинекологический осмотр).

После 3-х месячного курса лечения в ходе комплексного обследования получены следующие

Таблица 1 - Показатели субъективных данных при дисгормональных нарушениях молочной железы до и после лечения Мастодином (n= 30)

Клинические симптомы	До лечения		После лечения	
	абс.	отн., %	абс.	отн., %
Масталгия	22	73,3	18	81,8
Нормализация менструального цикла	8	60	6	75
Примечание: 0,001 < p < 0,01				

результаты. У больных со средней степенью тяжести фиброзно-кистозной, диффузной формой мастопатий эффективность Мастодиона составила 72,5%, а с тяжелой формой - 35,2%. У 18 (81,8%) больных из 22, страдавших масталгией до лечения, исчез болевой синдром, чувство тяжести, жжения в груди после первой недели терапии, прекратился дискомфорт в молочных железах в предменструальном периоде. У 6 (75%) пациенток из 8 отмечалась нормализация менструального цикла (Табл.1)

При контрольном обследовании 30 пациенток через 3 месяца после начала лечения отмечался положительный эффект в ультразвуковой и рентгенологической картине. Результаты динамического и маммографического и УЗИ наблюдения пациентов с различными формами фиброзно-кистозной мастопатии представлены в таблице 2.

Как видно из представленной таблицы, положительная динамика отмечалась у 19 (63,3%) пациенток из 30 при комбинированном лечении дисгормональных нарушений молочной железы Мастодином и сопутствующих заболеваний щитовидной железы, яичников. Положительная динамика заключалась в уменьшении плотности железистого и фиброзного компонента за счет снижения объема гиперплазированных элементов, не возникали новые узловые образования. При контрольных динамических УЗИ исследованиях был отмечен регресс кист: уменьшение их количества и диаметра, а также их исчезновение, уменьшение диаметра протоков. У 2 пациенток на фоне лечения Мастодином и лечения патологии со стороны щитовидной железы и яичников отмечалось полное рассасывание формирующихся фиброаденом. У 1 пациентки на фоне лечения Мастодином и удаления кисты яичника отмечалось полное рассасывание внутримолочного образования молочной железы.

Стабилизация процесса отмечалась у 11 (36,7%) пациентов, которым проводилось лечение только Мастодином, без лечения сопутствующей патологии (по тем или иным причинам не выполняли назначения эндокринолога и гинеколога). Стабилизация процесса выявлена у 4 (40%) с ФКМ с преобладанием кистозного компонента, у 3 (37,5%) с ФКМ с преобладанием фиброзного компонента и также у 3 (37,5%) с диффузной ФКМ с преобладанием железистого компонента.

Ни в одном случае не отмечалось ухудшения состояния молочных желез. Побочные эффекты при приеме Мастодиона не наблюдались.

Таблица 2 - Показатели объективных данных при дисгормональных нарушениях молочной железы на фоне консервативной терапии (по данным маммографии и УЗИ исследования)

Формы ФКМ	Положит. динамика		Стабилизация процесса	
	абс.	отн., %	абс.	отн., %
ФКМ с преобладанием кистозного компонента n= 10	6	60	4	40
ФКМ с преобладанием фиброзного компонента n= 8	5	62,5	4	37,5
Диффузная ФКМ с преобладанием железистого компонента n= 8	5	62,5	3	37,5
Формирующаяся фиброаденома n= 2	2	100	3	
Внутримолочные образования n= 2	1	50	1	50
Всего	19	63,3	11	36,7
Примечание: 0,001 < p < 0,01				

Выводы:

У больных со средней степенью тяжести фибронокистозной, диффузной формой мастопатий эффективность Мастодиона составила 72,5%, а с тяжелой формой - 35,2%.

У 18 (81,8 %) больных из 22, страдавших масталгией до лечения, исчез болевой синдром после первой недели терапии, у 6 (75%) пациенток из 8 отмечалась нормализация менструального цикла

Положительная динамика отмечалась у 19 (63,3%) пациенток из 30 при комбинированном лечении дисгормональных нарушений молочной железы Мастодином и сопутствующих заболеваний щитовидной железы, яичников.

Стабилизация процесса отмечалась у 11 (36,7%) пациентов, при лечении только Мастодином, без терапии сопутствующей патологии, у 4 (40%) с ФКМ с преобладанием кистозного компонента, у 3 (37,5%) с ФКМ с преобладанием фиброзного компонента и также у 3 (37,5%) с диффузной ФКМ с преобладанием железистого компонента.

Эффект при применении Мастодиона достигает от 3 до 6 месяцев, что зависит от формы мастопатии и от размера формирующихся фиброаденом, также связано с глубинными механизмами воздействия на регуляцию гормонально-метаболических процессов в организме.

Список литературы

1. Практическая маммология. Под редакцией М.И.Давыдова, В.П.Летягин - Практическая медицина. - М., 2007.
2. Черенков В.Г. Клиническая онкология. - М., 2005. - С. 187-189.
3. Зотов А.С., Белик Е.О. Мастопатия и рак молочной железы. - М., 2005.
4. Джубалиев С.К., Пак Д.Д. Лечение рака и доброкачественных заболеваний молочной железы. - Казань, 2004. - С. 106-110.
5. Бурдина Л.М., Бурдина И.И. Мастодион и его роль в лечении доброкачественных заболеваний молочных желез // Маммология. - 1998. - №3. - С. 72-79.

ТҰЖЫРЫМ

Г.А.Тлеугаблова, Б.Ш.Кожасхметов, Р.Р.Абдулаханова, Ж.Ж.Калиева

Сүт безінің дисгормональды бұзылыстының

Алматылы Мемлекеттік дәрігерлерді жетілдіру институты

Препарат Мастодионды қолдану терапияның алғашқы аптасынан-ақ ауыру синдромын анық түрде азайтуға септігін тигізеді. Мастодионның тиімділігі мастопатияның фиброз-кистозды және диффуздық калпының орта ауырлығы бар пациенттер арасында 72,5% құраса, ауырлығы жоғары формаларында 35,2% құрады. Мастодион мастопатияның түрлі калыптарындағы гормональді нормалайтын тиімді де қауіпсіз құрал болып табылады. Алынған нәтижелер сүт безінің дисгормональды бұзылуларын түзейтін жаңа тәсілдер табылғандығын көрсетеді. Мастодион препаратын қолдану аталып кеткен бұзылулар терапиясында, яғни мақсатты әрекетететін терапияда жаңа бір бағыт ашады. Сүт безінің дисгормональды бұзылуларын емдеуде дәрігерлер практикасында бұндай терапия басты бағыт болуы қажет.

Түйінді сөздер: сүт безі, мастопатия, Мастодион.

SUMMARY

Tleugabilova G.A., Kozhahmetov, B.Sh., Abdulahanova R.R., Kalieva Z.Z.

Almaty State Institute of Advanced Medical Treatment of violations of breast cancer

Using of vegetable preparation Mastodinon could contribute to reliable reducing of pain syndrome from the first week of therapy. Efficiency of Mastodinon is 72.5% among the patients with medium-scale of severity of fibro-polycystic and diffusive forms of mastopathy, and 35.2% among the patients with heavy-scale forms of mastopathy. Mastodinon is efficient and safety remedy for normalization of hormonal balance in different forms of mastopathy, which shapes (forms) from fibroadenomas. Getting results indicates new ways of correction disharmonic imbalances of mammary gland. Using of preparation Mastodinon opens new direction in purposive actuating therapy. That kind of therapy should be preemptive in treatment of disharmonic imbalances of mammary gland among practical doctors.

Keywords: breast, breast, Mastodinon.